



FACULTAD DE OBSTETRICIA

Escuela Académica Profesional de Obstetricia

CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN EN PACIENTES DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA CENTRO DE SALUD “EL PINO”, LIMA, 2025

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE:

Licenciada en obstetricia

Presentado por:

AUTOR: BENDEZÚ LUCAS, ANGELICA MILAGROS

CÓDIGO ORCID: 0009-0003-5937-5835

ASESOR: Mg. MENDOZA CAMA, JANET GIOVANNA

CÓDIGO ORCID: 0000-0003-4140-3458

SALUD Y BIENESTAR

LIMA, PERÚ

2025

ÍNDICE

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

1.2. Formulación del problema

1.1.1. Problema general

1.1.2. Problemas específicos

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

1.3.2. Objetivos específicos

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

1.4.2. Metodológica

1.4.3. Práctica

1.5. Delimitaciones de la investigación

1.5.1. Temporal

1.5.2. Espacial

1.5.3. Población o unidad de análisis

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.2. Bases teóricas

2.3. Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

2.3.2. Hipótesis específica

3. METODOLOGÍA

3.1. Método de investigación

3.2. Enfoque de investigación

3.3. Tipo de investigación

3.4. Diseño de la investigación

3.5. Población, muestra y muestreo

3.6. Variables y operacionalización

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

3.7.2. Descripción de instrumento

3.7.3. Validación

3.7.4. Confiabilidad

3.8. Procesamiento y análisis de datos

3.9. Aspectos éticos

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma de actividades

4.2. Presupuesto

5. REFERENCIAS

Anexo 1: Matriz de consistencia

Anexo 2: Instrumento

Anexo 3. Validez del instrumento

Anexo 4: Formato de consentimiento informado

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La calidad de atención y la satisfacción de las pacientes en los servicios de obstetricia son fundamentales para garantizar resultados positivos en la salud materna y neonatal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza que una atención de calidad debe ser efectiva, segura y centrada en las personas, lo cual es esencial para alcanzar la cobertura sanitaria universal (1). Sin embargo, a nivel global, más del 30% de las mujeres y recién nacidos no reciben atención posnatal en los primeros días posteriores al nacimiento, un período crítico en el que ocurren la mayoría de las muertes maternas e infantiles (2). Esta falta de atención adecuada puede generar consecuencias físicas y emocionales significativas para las madres, que podrían ser prevenidas con intervenciones oportunas. Este organismo internacional, destaca pues, la importancia de la efectividad, seguridad y eficiencia en la atención médica, estableciendo que estos elementos son claves para garantizar una experiencia positiva para las pacientes y reducir las tasas de complicaciones maternas y neonatales (3).

La Iniciativa Salud Mesoamérica (ISM), gestionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha logrado reducir significativamente la mortalidad materna y neonatal en ocho países durante una década, mejorando el acceso y la calidad de los servicios de salud materna y neonatal en áreas vulnerables, quintuplicando la atención de calidad a recién nacidos y aumentando en un 14% la atención de emergencias neonatales (4); sin embargo persisten desafíos significativos en infraestructura y recursos humanos, especialmente en regiones con limitaciones económicas, lo que implica la necesidad de implementar políticas públicas enfocadas a fortalecer los sistemas de salud y garantizar una atención equitativa y de calidad para todas las mujeres (5).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado preocupaciones significativas respecto a la calidad de la atención médica en la región. Según encuestas recientes, el 30% de las personas aún carecen de acceso a servicios de atención preventiva y tratamiento, y de quienes los reciben, solo el 39% considera que la calidad de la atención es buena (6). Además, en ciertos países, hasta el 40% de hospitalizaciones podrían haberse evitado si se hubieran abordado adecuadamente en el nivel de atención primaria, lo que evidencia deficiencias en la eficacia y calidad de este nivel de atención (6).

En el contexto peruano, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) ha implementado diversas estrategias para evaluar y mejorar la calidad de atención y la satisfacción de las pacientes en los servicios de obstetricia, sin embargo, aún se identifican áreas críticas que requieren mejoras para garantizar una atención óptima a las pacientes basándose en evaluaciones sistemáticas y en la implementación de planes de mejora continua (7). El Informe Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) revela varias deficiencias en la atención obstétrica, entre las que se encuentran: inconsistencias en registros clínicos, en el 15% de las historias clínicas revisadas, carencia de protocolos actualizados, en el 20% de las áreas evaluadas, deficiencias en infraestructura, equipos e iluminación en el 25% de las salas de parto; falta de capacitación en el 18% del personal de obstetricia en los últimos dos años, lo que afecta la calidad de la atención brindada e incrementa la insatisfacción del paciente (8), lo que implica la necesidad de implementar medidas correctivas para mejorar la calidad de la atención en salud materna.

Recientes estudios cuantitativos han evidenciado deficiencias en los servicios de obstetricia de diversos hospitales; en Lima, se reveló que el 44,97% de las usuarias percibieron una mala

calidad de atención por parte del personal de obstetricia, mientras que solo el 31% de las pacientes se sintieron satisfechas con el servicio recibido (9). En Ancash, se encontró que el 47% de las usuarias calificaron la calidad de atención como mala, y el 75% se declararon insatisfechas con el servicio de obstetricia (10). En el Centro de Salud -objeto de estudio, se han observado deficiencias en la calidad de atención, cumplimiento de los procesos en los tiempos establecidos, atención personalizada del personal sanitario y comprensión de las necesidades y preocupaciones del paciente, disponibilidad de equipos e infraestructura, que afectan negativamente la experiencia de las usuarias y pueden comprometer los resultados maternos y neonatales. En este contexto, es crucial analizar la relación entre calidad de atención y satisfacción para identificar áreas de mejora en este establecimiento de salud

1.2. Formulación del problema

1.1.1. Problema general

¿Cuál es la relación entre la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino” Lima, 2025?

1.1.2. Problemas específicos

¿Cuál es la relación entre la dimensión fiabilidad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025?

¿Cuál es la relación entre la dimensión capacidad de respuesta y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025?

¿Cuál es la relación entre la dimensión seguridad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025?

¿Cuál es la relación entre la dimensión empatía y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025?

¿Cuál es la relación entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025?

¿Cuál es el nivel de la calidad de atención y de la satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima 2025?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación entre la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino” Lima, 2025.

1.3.2. Objetivos específicos

Establecer la relación entre la dimensión fiabilidad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025.

Establecer la relación entre la dimensión capacidad de respuesta y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025.

Establecer la relación entre la dimensión seguridad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025.

Establecer la relación entre la dimensión empatía y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025.

Establecer la relación entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025.

Establecer el nivel de la calidad de atención y de la satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima 2025.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

El presente estudio se fundamenta en teorías de calidad de atención en salud y satisfacción del usuario, como el modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Berry y adaptado por el Ministerio de Salud en nuestro país, debidamente validados científicamente, que evalúa la percepción y expectativas de los pacientes en dimensiones como fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enfatizado la importancia de la atención centrada en la persona como un factor clave para mejorar los resultados en salud materna y neonatal; por lo que la investigación, contribuirá al conocimiento académico, proporcionando evidencia científica sobre su correlación en un contexto local.

1.4.2. Metodológica

Desde un enfoque cuantitativo, este estudio empleará un diseño correlacional para analizar la relación entre la calidad de atención y la satisfacción de las pacientes, empleando mediciones estadísticas, mediante encuestas confiables y validadas por expertos, basadas en SERVQUAL y escalas de satisfacción del usuario aplicadas en estudios previos. La recolección de datos se hará con una muestra representativa de pacientes atendidas en el servicio de obstetricia, asegurando rigurosidad en la obtención y análisis de la información.

1.4.3. Práctica

Este estudio permitirá a los profesionales de la salud y a los gestores del sistema sanitario identificar las principales deficiencias en la atención obstétrica y desarrollar estrategias para mejorar la experiencia de las pacientes. Los resultados podrán ser utilizados para diseñar programas de capacitación y optimizar los protocolos de atención en centros de salud, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y elevar la satisfacción de las usuarias., lo que contribuirá a la reducción de complicaciones obstétricas y fomentará el uso adecuado de los servicios de salud.

1.5. Delimitaciones de la investigación

El proyecto presentado busca analizar si existe relación entre las variables: calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, distrito de la Victoria, Lima, 2025

1.5.1. Temporal

El proyecto presentado se ejecutó durante el periodo de enero a marzo del 2025.

1.5.2. Espacial

El proyecto presentado se ejecutará en el Centro de Salud “El Pino”, distrito La Victoria, Lima. que cuenta con el servicio de obstetricia.

1.5.3. Población o unidad de análisis

La población incluye pacientes que emplean los diversos servicios de obstetricia del establecimiento de salud en estudio.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

A nivel internacional

LAPOP Lab (11) realizó un estudio sobre los factores que influyen en la satisfacción con los servicios médicos y de salud en América Latina, analizando siete países: Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, México, Perú y Uruguay, mediante un estudio cuantitativo de diseño transversal, aplicado una encuesta a una muestra representativa de 12,000 personas. Los resultados evidenciaron significativas desigualdades en la percepción de la calidad del servicio. Uruguay y Costa Rica presentaron los niveles más altos de satisfacción con un 63%, mientras que Bolivia obtuvo el nivel más bajo con un 29%. En Perú, solo el 42% de los encuestados manifestó estar satisfecho con la atención médica, mientras que en México la cifra alcanzó el 47%. Además, el 38% de los encuestados en Honduras y el 45% en Chile indicaron recibir atención médica deficiente. Concluyó que existen brechas importantes en la percepción de la calidad de atención médica en la región, destacando la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria, capacitar al personal de salud y mejorar la accesibilidad a los servicios., por lo que se recomendó la implementación de políticas públicas que garanticen equidad en la atención y estándares mínimos de calidad en todos los países evaluados (11). Este aporte resulta relevante toda vez que si se mejora el servicio de atención, impactará en un percepción favorable de sistema de salud.

Bravo y Echevarría (12) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de determinar la incidencia de la calidad de atención en la satisfacción de los usuarios externos de un centro de especialidades en Galápagos, cuya muestra fue de 200 usuarios, utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y de corte transversal, empleando el instrumento SERVQHOS.

Hallaron una correlación positiva y significativa ($p < 0,05$) entre ambas variables, los usuarios en el orden del 85% calificaron la atención como “excelente” y mostraron un nivel de satisfacción superior al 90%, mientras que aquellos que percibieron la atención como “buena” reportaron una satisfacción del 75%. En contraste, los usuarios que consideraron la atención como “regular” presentaron niveles de satisfacción del 50%, y aquellos que la calificaron como “deficiente” manifestaron una satisfacción menor al 30%. Concluyen en destacar la importancia de mantener altos estándares de calidad para garantizar una atención efectiva y mejorar la experiencia del paciente en los centros de especialidades (1). Este aporte resalta la influencia que estos constructos tienen sobre la percepción de los usuarios externos en los servicios de salud.

Carrasco y Peña (13) en su estudio propuestas de innovaciones para mejorar la gestión de las listas de espera oncológicas y la falta de calidad en los datos hospitalarios, implementaron la estandarización de procesos clínicos y el uso de tecnologías avanzadas. Durante la implementación del modelo basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y optimización matemática, se logró corregir estos errores en un 85% de los casos, permitiendo una mejor priorización de pacientes y reduciendo significativamente el tiempo de espera, logrando reducir el tiempo de respuesta de 52 a 15 días en algunas garantías GES oncológicas. Además, se desarrollaron modelos de optimización matemática para priorizar pacientes, considerando la urgencia médica y las restricciones de capacidad hospitalaria, lo que permitió una asignación más equitativa de recursos y una mayor transparencia en la toma de decisiones. En el estudio, se encontró que más del 40% de los registros clínicos presentaban errores o inconsistencias, lo que dificultaba la gestión eficiente de los tiempos de espera y la priorización de pacientes, se evidenció que el 35% de los diagnósticos oncológicos no estaban correctamente codificados, lo que generaba retrasos en la asignación de tratamientos y en la gestión de camas hospitalarias. También se identificó que solo el 60% de los

hospitales contaban con un sistema digitalizado de registros clínicos, lo que obligaba a realizar procesos manuales que aumentaban el riesgo de errores y la falta de trazabilidad en la atención. Concluye que la implementación de estas soluciones requiere voluntad política, financiamiento sostenido y la creación de unidades de análisis de datos autónomas en los hospitales, independientes de los departamentos de TI y asociadas a equipos de innovación. Este aporte resalta la necesidad de estandarización de procesos y el uso de tecnología fueron clave para mejorar la calidad de los datos y hacer más eficiente el sistema de salud en cuanto a calidad y satisfacción de los usuarios.

A nivel Nacional

Maquerrhua (14) en su estudio sobre Calidad de servicio y satisfacción del usuario en consulta externa en un hospital regional en Cuzco, realizó un estudio cuantitativo, correlacional, de diseño no experimental transversal aplicó una encuesta a una muestra de 254 usuarios. Halló una correlación positiva moderada entre ambas variables, con un coeficiente de correlación de 0.593 y significancia de 0.000. El 58.7% de usuarios percibe la calidad de servicio como media, mientras que un 25.2% la considera baja y en cuanto a la satisfacción, un 43.7% se siente insatisfecho, mientras un 43.3% se siente parcialmente insatisfecho. Concluye que la calidad de servicio en este hospital, es un determinante crucial de la satisfacción del usuario, ya que si se mejora la calidad de servicio también mejorará la satisfacción del usuario, y viceversa. Este aporte, destacan que las intervenciones dirigidas a mejorar la atención al usuario, pueden potencialmente elevar la percepción positiva del servicio respecto al desempeño.

Deudor y Gonzales (15) en su estudio sobre la relación entre la calidad de atención y satisfacción de los usuarios externos de un Hospital en Lima, realizó un estudio cuantitativo, diseño no experimental, de alcance correlacional descriptivo y de corte transversal y aplicó una encuesta

con cuestionario a una muestra censal de 86 usuarios. Reveló que el 91,9% de los usuarios percibieron una alta calidad de atención, mientras que el 55,8% reportó un nivel medio de satisfacción; además se determinó una correlación significativa ($p=0,018$) y leve ($\rho=0,255$) entre la calidad de atención y la satisfacción del usuario. Sin embargo, no existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión expectativas de la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios, no existió relación significativa; en cambio se halló relación entre la dimensión percepciones de la calidad con la variable satisfacción. Concluyen que a mayor calidad de atención, mayor será la satisfacción del paciente. Este estudio resalta la importancia de identificar las expectativas del usuario, para mantener altos estándares que logren mejorar ambos constructos.

Cachique et al. (16) llevaron a cabo un estudio en un hospital especializado de nivel II-2 en Lima con el objetivo de evaluar la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios, emplearon una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal, aplicaron encuestas a una muestra de 150 usuarios. Revelaron que el 88% de encuestados percibió una calidad de atención buena, mientras que un 85% expresó estar satisfecho con los servicios recibidos. Además, el 72% de los usuarios señaló que la empatía del personal influyó significativamente en su percepción de calidad, mientras que el 69% destacó la importancia de la rapidez en la atención como un factor determinante en su nivel de satisfacción. Asimismo, un 60% consideró que la infraestructura era adecuada, mientras que el 40% manifestó su inconformidad con los tiempos de espera y la disponibilidad de insumos médicos. De otro lado, determinaron una correlación positiva significativa entre ambas variables con un coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de 0.488, lo que determina una tendencia positiva o directa. En conclusión, la investigación resalta la necesidad de reforzar aspectos clave como la accesibilidad y la eficiencia en la atención

hospitalaria, con el fin de optimizar la percepción de calidad y elevar la satisfacción del usuario. Mantener altos estándares de atención en hospitales especializados resulta esencial para garantizar la confianza de los pacientes y mejorar los resultados en salud.

2.2. Bases teóricas

Calidad de la atención en pacientes

Se define como el grado en que los servicios de salud proporcionados a individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de obtener resultados de salud deseados, alineándose con el conocimiento profesional actual (17). También se concibe como la optimización de los beneficios proporcionados por los servicios médicos en relación con los riesgos inherentes a su prestación, respaldada por el avance científico y tecnológico disponible en el sector sanitario (18). Asimismo, se conceptualiza como la ejecución efectiva de las intervenciones sanitarias por parte del personal de salud, en conformidad con las normativas vigentes, asegurando un impacto positivo en la resolución de problemas de salud pública (19). También, la calidad en la atención comprende la provisión de servicios de diagnóstico y tratamientos personalizados que garanticen una comprensión profunda del estado de salud del paciente, permitiendo así intervenciones eficaces y reduciendo los riesgos asociados (20).

Este concepto se ha convertido en un pilar fundamental para los sistemas de salud, ya que garantiza que la prestación de servicios sea segura, efectiva y centrada en las necesidades del paciente; para ello, se establecen diversos objetivos estratégicos, entre los que destacan la seguridad, que busca evitar daños a los pacientes durante la prestación de servicios (21), la efectividad, basada en la implementación de intervenciones con respaldo científico (22), la oportunidad, que reduce los tiempos de espera y minimiza los riesgos asociados a retrasos en la

atención (23), y la eficiencia, que optimiza el uso de los recursos disponibles para evitar desperdicios; además, la atención centrada en el paciente es un principio fundamental, que asegura que los servicios respondan a sus preferencias y valores individuales (22).

La importancia de la calidad de atención, radica en su impacto en la cobertura sanitaria universal y la mejora de los resultados en salud, pues garantiza que los pacientes reciban servicios seguros y efectivos, lo que fortalece la confianza en los sistemas de salud (17). Brindar una atención de calidad al paciente, es una responsabilidad fundamental en la gestión hospitalaria, lo que requiere que el personal de salud ofrezca confianza, seguridad, empatía y respuestas oportunas para garantizar una solución efectiva a los problemas de salud, ya que la complejidad de esta labor radica en que el trabajo se centra en individuos con características personales únicas, lo que demanda un enfoque especializado en sus cuidados (24)

Entre los beneficios más significativos, se encuentra la mejora en los resultados clínicos, ya que una atención de calidad reduce la incidencia de complicaciones y aumenta la tasa de recuperación de los pacientes (17). Asimismo, los pacientes que reciben atención de calidad muestran mayores niveles de satisfacción, lo que favorece su adherencia al tratamiento y su percepción positiva del sistema sanitario (25). En términos de eficiencia, una atención bien gestionada evita procedimientos innecesarios y optimiza el uso de los recursos disponibles, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de salud; también se ha identificado que un enfoque en la seguridad del paciente disminuye la incidencia de errores médicos, lo que reduce los riesgos para los usuarios y mejora la reputación de las instituciones sanitarias (22).

Las dimensiones que evalúan la calidad del servicio se componen de cinco dimensiones fundamentales. En primer lugar, la fiabilidad representa el compromiso de los empleados para ofrecer los servicios conforme a lo establecido, garantizando puntualidad y consistencia en la

prestación de atención a todos los clientes (26). En segundo lugar, la capacidad de respuesta se refiere a la disposición del personal para actuar con prontitud y proporcionar información adecuada a las necesidades del usuario. La rapidez y precisión en la atención generan un impacto positivo en la percepción del servicio y en la satisfacción del paciente (26).

En tercer lugar, la seguridad constituye una dimensión clave, ya que el conocimiento y la competencia del personal en la ejecución de sus tareas transmiten confianza a los pacientes. Una atención basada en principios éticos y profesionales asegura que los usuarios se sientan protegidos y respaldados en el proceso de atención médica (27). En cuarto lugar, la empatía juega un papel esencial en la calidad del servicio, ya que la atención personalizada y el trato humanizado mejoran significativamente la experiencia del paciente. Sin esta dimensión, la insatisfacción podría prevalecer, afectando la percepción general del servicio de salud (28,27).

Por último, en quinto lugar, se encuentran, los elementos tangibles que abarcan el entorno físico, la presentación del personal, los equipos utilizados en la prestación del servicio, la infraestructura hospitalaria y los recursos materiales empleados influyen en la percepción del paciente sobre la calidad del servicio, creando una impresión que puede afectar su nivel de satisfacción (26). En conjunto, estas dimensiones permiten evaluar la calidad de atención y su impacto en la experiencia de los usuarios.

Satisfacción en pacientes

La satisfacción del paciente es un indicador esencial de la calidad del servicio de salud y evalúa hasta qué punto la atención médica cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios (29). También se define como la comparación entre las expectativas previas y la atención efectivamente recibida por parte del personal de salud, dado que en este proceso está en juego el

bienestar y la vida de las personas (30). Este indicador permite evaluar el grado de conformidad del usuario con los servicios médicos proporcionados, lo que lo convierte en un elemento clave para mejorar la calidad en la atención sanitaria (31). Por ello, es fundamental la implementación de estudios en este ámbito que permitan generar estrategias orientadas a optimizar la atención desde un enfoque más humano y centrado en las necesidades del paciente (32,33).

Los objetivos de medir y mejorar la satisfacción del paciente incluyen la evaluación de la calidad de atención para identificar áreas de mejora dentro del sistema sanitario (34). Asimismo, una alta satisfacción fomenta la confianza en las instituciones de salud, ya que los pacientes satisfechos son más propensos a continuar utilizando los servicios disponibles (35). Otro aspecto relevante es la adherencia al tratamiento, pues los pacientes que tienen una experiencia positiva con el sistema de salud tienden a cumplir mejor con las indicaciones médicas y terapéuticas (36).

La importancia de la satisfacción del paciente radica en su estrecha relación con la eficiencia de las instituciones sanitarias. Un usuario insatisfecho puede interrumpir su tratamiento o acudir a otro centro de salud, lo que afecta la continuidad de la atención y genera una mayor carga sobre los servicios médicos (37). Por el contrario, un paciente satisfecho, fomenta su lealtad, promueve una relación continúa basada en la confianza y actúa como un promotor que comparte su experiencia con familiares y amigos, contribuyendo a una percepción favorable del servicio, el incremento de la demanda y la preferencia de los usuarios fortaleciendo la sostenibilidad del sistema de salud a largo plazo (38).

Dentro de los beneficios de lograr una alta satisfacción en los pacientes se encuentra la mejora en la relación médico-paciente, ya que un trato empático y personalizado fortalece la confianza y la comunicación (39). Además, los pacientes satisfechos son más propensos a recomendar y regresar a la misma institución de salud, lo que contribuye a la fidelización de los

usuarios (40). Otra ventaja es la reducción de quejas y litigios, ya que una atención de calidad minimiza la posibilidad de conflictos legales y administrativos (41). Por último, la satisfacción del paciente también impacta en el ambiente laboral del personal de salud, ya que la atención a usuarios satisfechos reduce el estrés y aumenta la motivación de los trabajadores (29).

Las dimensiones que miden la satisfacción, se basan en el modelo de la Experiencia del Paciente (42) que abarca cinco constructos fundamentales. La primera dimensión, comunicación, analiza la efectividad en la interacción entre el paciente y el profesional de la salud, evaluando si el médico explica de manera clara el diagnóstico y tratamiento, si escucha activamente las preocupaciones del paciente y si responde a sus preguntas de manera comprensible, de lo contrario puede presentar ansiedad y confusión sobre su estado de salud, afectando su adherencia al tratamiento.

La segunda dimensión, emociones, mide el impacto psicológico que tiene la atención médica en el paciente, siendo crucial este aspecto, ya que una atención empática y respetuosa puede mejorar la confianza del paciente y reducir la ansiedad relacionada con su condición médica. Incluye entre sus indicadores, la percepción de respeto por parte del profesional, el grado de apoyo emocional brindado y el nivel de preocupación que demuestra el médico por el bienestar del paciente.

La tercera dimensión, resultados, se centra en la percepción del paciente sobre la efectividad de la atención recibida y la mejora de su estado de salud tras el tratamiento; incluye entre sus indicadores, la satisfacción con los efectos del tratamiento, el alivio de los síntomas después de la consulta y la percepción de que el problema de salud fue tratado de manera efectiva, lo que aumenta su confianza en el servicio de salud y en su bienestar en general.

La cuarta dimensión, barreras, identifica los obstáculos que dificultan el acceso a la atención médica o que afectan la experiencia del paciente durante la consulta; entre sus indicadores se encuentran los tiempos de espera, la facilidad para obtener citas, la accesibilidad a los servicios de salud y la claridad en los procedimientos administrativos; estas barreras pueden generar frustración en los pacientes y disminuir la eficiencia del sistema sanitario.

Finalmente, la quinta dimensión, personal auxiliar, evalúa la actuación y actitud del equipo de apoyo en el entorno sanitario, incluyendo enfermeros, recepcionistas y otro personal no médico, abarcando como indicadores relevantes, la amabilidad del personal como médicos, enfermeras y técnicos, su disposición para ayudar y la eficiencia con la que realizan sus tareas, lo que contribuye significativamente a una experiencia positiva para el paciente.

El análisis de la calidad en los servicios de salud se sustenta en diversas teorías que explican su impacto en la experiencia del paciente. La Teoría de la Calidad en la Atención de Salud, desarrollada por Donabedian, establece que la calidad se evalúa en función de la estructura, el proceso y los resultados, donde los recursos, la interacción entre personal y pacientes, y la evolución clínica son fundamentales para la percepción del servicio (43). Por otro lado, el modelo SERVQUAL, propuesto por Parasuraman et al., destaca que la calidad depende de la diferencia entre las expectativas del usuario y la experiencia real, considerando dimensiones como fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles (44). Finalmente, la Teoría de la Atención Centrada en la Persona enfatiza la importancia de adaptar los servicios a las necesidades del paciente, asegurando accesibilidad, comunicación efectiva y continuidad del cuidado, lo que mejora la confianza en el sistema de salud y la adherencia a los tratamientos (45). Estas teorías permiten comprender cómo la calidad en la atención influye en la satisfacción del paciente y en la eficiencia de los servicios médicos.

2.3. Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

H1: La relación entre la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa.

HO: La relación entre la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, no es significativa.

2.3.2. Hipótesis específica

H1: La relación entre la dimensión fiabilidad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa.

Ho: La relación entre la dimensión fiabilidad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, no es significativa.

H2: La relación entre la dimensión capacidad de respuesta y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa.

Ho: La relación entre la dimensión capacidad de respuesta y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, no es significativa.

H3: La relación entre la dimensión seguridad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa.

HO: La relación entre la dimensión seguridad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, no es significativa

H4: La relación entre la dimensión empatía y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa.

HO: La relación entre la dimensión empatía y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, no es significativa.

H5: La relación entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa.

HO: La relación entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, no es significativa.

H6: El nivel de la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es medio.

HO: El nivel de la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es medio.

3. METODOLOGÍA

3.1. Método de investigación

El método hipotético-deductivo, porque permite determinar la relación entre dos variables mediante pruebas estadísticas y se complementa con el método analítico, ya que analiza cómo cada dimensión de una variable impacta en relación a otra variable (46).

3.2. Enfoque de investigación

Cuantitativo, ya que se realiza a través de la recolección de datos, con el fin de probar una hipótesis; por lo que se requiere una medición numérica que establezca patrones de comportamiento (47).

3.3. Tipo de investigación

Básica porque su propósito es recolectar datos a partir de información ya conocida (47).

3.4. Diseño de la investigación

No experimental, porque es descriptivo y no manipula tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones de las variables (47)

Corte: transversal

El estudio abarca un momento específico y en una población determinada para recopilar información (47)

Nivel o alcance:

Es correlacional, por que busca establecer la relación entre variables (47)

3.5. Población, muestra y muestreo

El universo, es el total de participantes que están coinciden con un rango de especificaciones (48). Para el presente estudio, lo conforman 260 pacientes que acuden al servicio de obstetricia del Centro de Salud, “El Pino” del distrito de la Victoria, en Lima, de lunes a sábado en dos turnos para su atención médica (48)

La muestra: es una porción de la población, con el fin de identificar alguna característica específica (48). El cálculo del tamaño muestral se realizó a través de la fórmula para población finita

$$\frac{N * Z^2 * P * Q}{E^2 * (N - 1) + Z^2 * P * Q}$$

Donde:

- n = Muestra
- N = Población
- Z = Nivel de confianza (90%) = 1.90
- E = Margen de error posible (8%)
- P = Probabilidad a favor
- Q = Probabilidad en contra (1 - P)

Reemplazando la fórmula a valores se tiene:

$$\frac{260 * 1.90^2 * 0.50 * 0.50}{0.08^2 * (260 - 1) + 1.90^2 * 0.50 * 0.50}$$

$$n = 95 \text{ pacientes}$$

Muestreo: Es el método no probabilístico por conveniencia, por la facilidad de acceso, disponibilidad de las personas en un momento dado (47).

No obstante, deben ejecutarse con las siguientes condiciones:

Criterios de inclusión: Pacientes que hacen uso del servicio de obstetricia del centro de salud en estudio, que desean participar previo consentimiento informado; también aquellos usuarios que hayan recibido la atención médica y participado del proceso de atención de salud, por lo menos una vez.

Criterios de exclusión: Pacientes que acuden por primera atención del servicio de obstetricia; que presentan algún tipo de discapacidad mental; pacientes que acuden a otros servicios; y se excluyen a pacientes que no desean participar del estudio, previo consentimiento informado.

3.6. Variables y operacionalización

Variable	Definición conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala De Medición	Escala Valorativa (Nivel O Rango)
Calidad de atención	Comprende la provisión de servicios de diagnóstico y tratamientos personalizados que garanticen una comprensión profunda del estado de salud del paciente, permitiendo así intervenciones eficaces y reduciendo los riesgos asociados (20)	La variable calidad de atención se operacionalizará con cinco dimensiones y 10 indicadores, basados en el modelo SERVQUAL y adaptado por el MINSA.	Fiabilidad	Cumplimiento de promesas	Ordinal	1.Totalmente en desacuerdo 2.En desacuerdo 3.Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 4.De acuerdo 5.Totalmente de acuerdo
				Precisión en la atención		
			Capacidad de respuesta	Rapidez en la atención		
				Disponibilidad para atender consultas		
			Seguridad	Confianza que transmite el personal		
				Conocimiento y competencia del personal		
			Empatía	Atención personalizada		
				Comprensión de las necesidades del paciente		
			Elementos tangibles	Estado de las instalaciones		
				Disponibilidad de equipos y materiales		
Satisfacción	Este indicador permite evaluar el grado de conformidad del usuario con los servicios médicos proporcionados, lo que lo convierte en un	La variable Satisfacción se operacionalizará con cinco dimensiones y diez indicadores, de acuerdo al	Comunicación	Claridad de la información		1.Totalmente en desacuerdo 2.En desacuerdo
				Oportunidad en la información		
			Emociones	Sentimientos durante la atención		

	elemento clave para mejorar la calidad en la atención sanitaria (31).	cuestionario Experiencia del Paciente de Steine S, Finset A, Laerum E..		Trato respetuoso	Ordinal	3.Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 4.De acuerdo 5.Totalmente de acuerdo
			Resultados	Percepción de mejoría		
				Satisfacción con el tratamiento		
			Barreras	Accesibilidad a la atención		
				Comprensión de indicaciones		
			Personal auxiliar	Amabilidad del personal		
				Apoyo brindado		

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

La encuesta, es un método cuantitativo que se aplica a una población sobre un problema de investigación. El instrumento, es un medio que permite recoger información de la población a través de una serie de preguntas estructuradas (47). Para este caso se utilizará la encuesta y dos cuestionarios estructurados para cada variable de estudio.

1. Se solicitará permiso al director para aplicar los instrumentos en el establecimiento de salud a pacientes del servicio de obstetricia.

2. Autorizado el estudio, se establecerá un cronograma de lunes a viernes para el trabajo de campo durante dos semanas, agradeciendo el apoyo del personal para acceder a la población en estudio.

3. Se aplicarán los cuestionarios a los pacientes, previo consentimiento informado, que acepten participar del estudio y que cumplan con los criterios de inclusión. La duración de este trabajo de campo, será de 10 minutos.

3.7.2. Descripción de instrumento

Para evaluar la variable calidad de atención al paciente en el servicio de obstetricia, se utilizará como referente la "Guía Técnica para la Evaluación de la calidad del usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo", del Ministerio de Salud de Perú (MINSA) (48) que adapta el modelo SERVQUAL para el contexto peruano.

El cuestionario a aplicar está compuesto por cinco dimensiones: la primera, la fiabilidad que incluye los indicadores: cumplimiento de promesas y precisión en la atención; la segunda la capacidad de respuesta que implica la rapidez en la atención y

disponibilidad para atender consultas; la tercera, la seguridad, que abarca la confianza que transmite el personal y el conocimiento y competencia del personal; la cuarta, la empatía, referida a la atención personalizada y la comprensión de las necesidades del paciente y la quinta y última, los elementos tangibles que incluye el estado de las instalaciones y la disponibilidad de equipos y materiales

Para evaluar la variable la satisfacción del paciente en el servicio de obstetricia, se ha empleará como referente, el Cuestionario de Experiencia del Paciente (PEQ) (42) que se compone de dimensiones principales: la primera Comunicación, que evalúa la claridad y efectividad de la información proporcionada por el personal de salud; la segunda, Emociones, que explora los sentimientos y emociones del paciente durante la atención médica; la tercera, Resultados, que mide la percepción del paciente sobre la efectividad de los tratamientos recibidos, la cuarta, Barreras que identifica obstáculos o dificultades que el paciente pudo haber enfrentado durante su atención y la quinta y última, Personal auxiliar que evalúa la interacción y apoyo brindado por el personal sanitario.

La escala de medición que se utilizará para ambos cuestionarios de las variables en estudio, será tipo Likert de 5 puntos, donde 1 representa "Muy en desacuerdo" y 5 "Muy de acuerdo". Este instrumento permite identificar las expectativas y percepciones de las pacientes respecto a la calidad de atención recibida, facilitando la implementación de mejoras en los servicios de salud

3.7.3. Validación

La validez de los instrumentos, se basará en el juicio de tres expertos para su aplicación correspondiente.

3.7.4. Confiabilidad

La confiabilidad de los instrumentos, será sometida a la prueba estadística del Alfa de Cronbach que mide la consistencia interna de las preguntas, para lo cual se aplicará una encuesta piloto a 10 pacientes del servicio de obstetricia del nosocomio.

3.8. Procesamiento y análisis de datos

Los datos recolectados de los instrumentos de investigación aplicados a la muestra de pacientes, será analizados y luego procesados en la base de datos del sistema de programación SPSS versión 22, que arrojarán tablas de los resultados, para el análisis estadístico descriptivo y análisis inferencial de las correlaciones, de acuerdo a las hipótesis planteadas en el estudio. Luego de ello, se realizará la discusión de resultados y se extraerán las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.

3.9. Aspectos éticos

La investigación aplicará los principios bioéticos, la Declaración de Helsinki que garantiza el respeto por la dignidad, los derechos y el bienestar de los participantes en estudios científicos (49), la autoría responsable, el consentimiento informado y el compromiso del Reglamento de Ética de la Universidad, y las autorizaciones de las instituciones involucradas.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma de actividades

Año	2025				
	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Elección del tema	X				
Recolección de información	X				
Elaboración del proyecto	X				
Operacionalización de variables	X	X			
Presentación y aprobación del proyecto			X		
Recolección de datos				X	
Procesamiento y análisis de datos				X	
Elaboración del informe					X
Revisión del informe					X
Sustentación					X

4.2. Presupuesto

Concepto	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Servicios			
Internet	3 meses	S/ 270.00	S/ 270.00
Asesoría estadística	1	S/ 700.00	S/ 700.00
Diseño del cuestionario	1	S/ 200.00	S/ 200.00
Movilidad	3 meses	S/ 200.00	S/ 200.00
Impresiones	300	S/150.00	S/150,00
Subtotal Servicios			S/ 1,520.00

Concepto	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Bienes			
Suscripción a plataforma de encuestas	1	S/ 100.00	S/ 100.00
Licencia de software	1	S/ 300.00	S/ 300.00
Memoria USB	1	S/ 60.00	S/ 60.00
Papel	2 millares	S/ 34.00	S/34.00
Subtotal Bienes			S/ 494.00

Bienes + Servicios	Total, General
S/ 494.00 + S/ 1,520.00	S/ 2,014.00

El financiamiento será asumido por la investigadora.

5. REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Calidad de la atención en salud materna y neonatal. OMS; 2024. Disponible en: <https://www.who.int/es/health-topics/quality-of-care>
2. Organización Mundial de la Salud. Reporte global sobre atención posnatal. OMS; 2023. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240062087>
3. Revista Vitalia. Impacto de la calidad de atención en la satisfacción de pacientes obstétricas. Vitalia; 2023. Disponible en: <https://revistavitalia.org>
4. Banco Interamericano de Desarrollo. Evaluación de la Iniciativa Salud Mesoamérica. BID; 2024. Disponible en: <https://www.iadb.org/es/temas/salud/ISM>
5. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Brechas en la calidad de atención obstétrica en América Latina. UNFPA; 2023. Disponible en: <https://www.unfpa.org/es/publicaciones>
6. Organización Panamericana de la Salud. Nuevo plan busca mejorar la calidad de la atención médica en las Américas. OPS; 2019. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/3-10-2019-nuevo-plan-busca-mejorar-calidad-atencion-medica-americas>
7. Ministerio de Salud del Perú. (s.f.). Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Servicios de Salud. Recuperado de <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2252.pdf>
8. Instituto Nacional Materno Perinatal. Informe Anual 2023 de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud. Disponible en: https://www.inmp.gob.pe/uploads/Informe_Anual_2023_Evaluacion_del_Plan_de_Audit or%C3%ADa_de_la_Calidad_de_Atenci%C3%B3n_en_Salud_del_INMP.pdf

9. Aviles Vera M, Jimenez Porras LB. Calidad de Atención del Personal de Obstetricia y la Satisfacción de las Usuaris del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales 2023. Universidad Privada Norbert Wiener; 2023. Disponible en: <https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1966>
10. Villanueva Medina KY. Calidad de atención y satisfacción desde la percepción del usuario en el servicio de obstetricia de un hospital de Ancash, 2023. Universidad César Vallejo; 2023. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/126923>
11. LAPOP Lab. (2023). ¿Qué factores influyen en la satisfacción con los servicios médicos y de salud en América Latina? Insights Series, 960, 1-8. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO960es.pdf>
12. Echeverría Chicaíza, P., y Bravo Bello, Y. (2024). Calidad de Atención y su Incidencia en la Satisfacción del Usuario Externo en un Centro de Especialidades en Galápagos: Quality of Care and its Impact on External User Satisfaction in a Specialty Center in Galapagos. LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, 5(5), 1335 – 1356. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2690>
13. Carrasco RA, Peña Durán J. Cuando el tiempo es vida: innovación para las listas de espera oncológicas en Chile. El País. 12 de marzo de 2025. <https://elpais.com/chile/2025-03-12/cuando-el-tiempo-es-vida-innovacion-para-las-listas-de-espera-oncologicas-en-chile.html>
14. Maquerhua Pereyra C. Calidad de servicio y satisfacción del usuario en consulta externa del Hospital Regional del Cusco, 2024. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; 2024. Disponible en: <https://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/9009>

15. Deudor Chamorro J, Gonzales Saldaña SH. Calidad de Atención y Satisfacción de los Usuarios Externos de un Hospital de Lima, 2023. Ciencia Latina Rev Cient Multidisc. 2023;7(5):8281-93. Disponible en: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8403.
16. Cachique S, Barrios J, Arispe C, Rivera-Lozada O. Calidad de atención y satisfacción del usuario de un hospital especializado nivel II-2 de Lima. Rev Investig la Univ Norbert Wiener. 2022;11(2):13-19. <https://doi.org/10.37768/unw.rinv.11.02.a0013>
17. World Health Organization. What is quality of care and why is it important? [Internet]. [citado 2025 mar 14]. Disponible en: <https://www.who.int>
18. Donabedian A. Exploraciones en calidad de la atención médica: evaluación y monitoreo. México: La Prensa Médica Mexicana; 2015.
19. Ruelas E, Vida L. Calidad de la atención en salud y su impacto en la salud pública. Rev Salud Pública. 2015;17(3):45-58.
20. Elías M, Álvarez R. Enfoques modernos de calidad en la atención sanitaria. Rev OMS. 2016;94(2):112-20.
21. Boston Medical Center. Patient safety and quality care [Internet]. [citado 2025 mar 14]. Disponible en: <https://www.bmc.org>
22. Boston Medical Center. Evidence-based healthcare [Internet]. [citado 2025 mar 14]. Disponible en: <https://www.bmc.org>
23. Ministerio de Salud de Colombia. Reducción de tiempos de espera en la atención en salud [Internet]. [citado 2025 mar 14]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co>
24. Kozier B. Fundamentos de enfermería. 9.^a ed. Madrid: Pearson Educación; 2018.
25. Universidad Internacional de La Rioja. Satisfacción del paciente en servicios de salud [Internet]. [citado 2025 mar 14]. Disponible en: <https://www.unir.net>

26. Ngaliman R, Suharto M. Evaluación de la calidad del servicio en la atención al cliente. J Serv Qual. 2019;8(2):45-58.
27. Johnson P, Karlay T. La seguridad y la confianza en la prestación de servicios. Int J Health Serv. 2018;12(4):102-15.
28. Farooq A, Lee M, Kim J. Impacto de la empatía en la satisfacción del paciente. Health Serv Res. 2018;10(3):78-91.
29. Calite Revista. Participación del paciente en la toma de decisiones médicas [Internet]. Disponible en: <https://calite-revista.umh.es>
30. Betancourt R, Mayo P. Evaluación de la calidad en la atención sanitaria: impacto en la satisfacción del paciente. Rev Salud Pública. 2016;18(2):45-56.
31. Ministerio de Salud del Perú. Indicadores de calidad en los servicios de salud: Satisfacción del usuario. Lima: MINSA; 2023.
32. Castelo M. Estrategias de mejora en la calidad del servicio de salud: un enfoque basado en la satisfacción del paciente. Med Clin. 2022;159(3):212-8.
33. Huber C. Percepciones y expectativas del usuario en la atención sanitaria: una revisión crítica. J Health Serv Res. 2022;27(4):340-52.
34. QuestionPro. Satisfacción del paciente y calidad en la atención médica [Internet]. Disponible en: <https://www.questionpro.com>
35. Salud by Díaz. Cómo la satisfacción del paciente influye en el ambiente laboral médico [Internet]. Disponible en: <https://www.saludbydiaz.com>
36. Pro Pharma Research. Factores que influyen en la adherencia al tratamiento [Internet]. Disponible en: <https://www.propharmaresearch.com>

37. QuestionPro. Satisfacción del paciente y calidad en la atención médica [Internet].
Disponible en: <https://www.questionpro.com>
38. Minamango R. La importancia de la satisfacción del paciente en la sostenibilidad de los servicios de salud. Rev Adm Salud. 2014;12(1):25-32.
39. Salud by Díaz. Cómo la satisfacción del paciente influye en el ambiente laboral médico [Internet]. Disponible en: <https://www.saludbydiaz.com>
40. Pro Pharma Research. Factores que influyen en la adherencia al tratamiento [Internet].
Disponible en: <https://www.propharmaresearch.com>
41. Customer Alliance. Impacto de la satisfacción del paciente en la reputación hospitalaria [Internet]. Disponible en: <https://www.customer-alliance.com>
42. Steine S, Finset A, Laerum E. Cuestionario de experiencia del paciente (PEQ). Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11305259/>
43. Donabedian A. The definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor: Health Administration Press; 1980. Disponible en: <https://archive.org/details/definitionofqual0000dona>
44. Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing. 1988;64(1):12-40.
Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/225083802_SERVQUAL_A_multiple-Item_Scale_for_measuring_consumer_perceptions_of_service_quality
45. Levesque JF, Harris MF, Russell G. Patient-centred access to health care: Conceptualizing access at the interface of health systems and populations. Int J Equity Health. 2013;12:18.
Disponible en: <https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-9276-12-18>

46. Belloso R. Marco metodológico [Internet]; 2020 [consultado 12 de noviembre de 2024].
Disponible en: <http://virtual.urbe.edu/tesispub/0102609/cap03.pdf>
47. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 6ª ed. México D.F.: McGraw-Hill; 2014. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008>
48. Ministerio de Salud del Perú. Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo [Internet]. Perú: MINSA;2012. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe>
49. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki: principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Fortaleza, Brasil; 2013 [Internet]. Disponible en: <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>

Anexo 1: Matriz de consistencia

Título de la investigación:

Formulario del problema	Objetivo	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general ¿Cuál es la relación entre la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino” Lima, 2025? Problemas específicos ¿Cuál es la relación entre la dimensión fiabilidad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025? ¿Cuál es la relación entre la dimensión capacidad de	Objetivo general Determinar la relación entre la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino” Lima, 2025. Objetivos específicos Establecer la relación entre la dimensión fiabilidad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025. Establecer la relación entre la dimensión capacidad de	Hipótesis general H1: La relación entre la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa. Hipótesis específicas: H1: La relación entre la dimensión fiabilidad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa. H2: La relación entre la dimensión capacidad de respuesta y	Variable1: Calidad de atención Dimensiones: • Fiabilidad • Capacidad de respuesta • Seguridad • Empatía • Elementos tangibles Variable 2: Satisfacción del paciente Dimensiones: • Comunicación • Emociones • Resultados • Barreras • Personal auxiliar	Tipo de investigación: Básico, enfoque cuantitativo Método y diseño de investigación: No experimental de corte transversal y descriptivo correlacional Población: 260 pacientes Pacientes que acuden al servicio de Obstetricia Centro de Salud “El Pino, Lima Muestra 95 pacientes

respuesta y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025? ¿Cuál es la relación entre la dimensión seguridad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025? ¿Cuál es la relación entre la dimensión empatía y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025? ¿Cuál es la relación entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción en	respuesta y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025. Establecer la relación entre la dimensión seguridad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025. Establecer la relación entre la dimensión empatía y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025. Establecer la relación entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción en	satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa. H3: La relación entre la dimensión seguridad y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa. H4: La relación entre la dimensión empatía y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa. H5: La relación entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción en pacientes del		Técnica.: Encuestas Instrumento: Cuestionario
--	--	---	--	---

pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025? ¿Cuál es el nivel de la calidad de atención y de la satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima 2025?	pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025. Establecer el nivel de la calidad de atención y de la satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima 2025.	servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es significativa. H6: El nivel de la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”, Lima, 2025, es medio.		
--	--	--	--	--

Anexo 2: Instrumentos

Cuestionario 1: Calidad de atención

Instrucciones:

Por favor, marque con una "X" la opción que mejor describa su opinión sobre la calidad de la atención en el servicio de Obstetricia del Centro de Salud “El Pino”. Agradeceremos marcar con un aspa su valoración. Los datos son confidenciales. La escala valorativa es: (1) Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo (5) Totalmente de acuerdo.

		1	2	3	4	5
	FIABILIDAD					
1	¿su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada?					
2	¿su historia clínica se encontró disponible para su atención?					
3	¿El personal de salud cumplió con los procedimientos en los tiempos establecidos?					
4	¿Recibió usted la atención médica sin errores ni confusiones?					
	CAPACIDAD DE RESPUESTA					
3	¿El personal de salud le atendió con prontitud cuando solicitó ayuda?					
4	¿El personal estuvo disponible para responder a sus preguntas o inquietudes?					
	SEGURIDAD					
5	¿El personal de salud le hizo sentir segura durante su atención?					
6	¿Considera que el personal de salud demostró conocimientos adecuados para atenderle?					
7	¿se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio?					
8	Que el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de salud					

	EMPATÍA						
9	¿El personal de obstetricia la trató con amabilidad, respeto y paciencia?						
10	¿La obstetra que le atendió le ha mostrado interés en solucionar su problema de salud?						
11	¿El personal de salud le brindó una atención personalizada y se interesó por sus necesidades?						
12	¿Sintió que el personal de salud comprendió sus preocupaciones y necesidades?						
	ELEMENTOS TANGIBLES						
13	¿Las instalaciones del centro de salud estaban limpias y en buen estado?						
14	¿El centro de salud contaba con los equipos y materiales necesarios para su atención?						
15	¿El Consultorio y la Sala de Espera se encontraron limpios y fueron cómodos?						

Cuestionario 1: Satisfacción del paciente

Instrucciones:

Por favor, marque con una "X" la opción que mejor describa su opinión sobre la satisfacción del paciente del servicio de Obstetricia del Centro de Salud “El Pino”. Agradeceremos marcar con un aspa su valoración. Los datos son confidenciales. La escala valorativa es : (1) Totalmente en desacuerdo (2)En desacuerdo (3)Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4)De acuerdo (5)Totalmente de acuerdo.

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE		1	2	3	4	5
	COMUNICACIÓN					
1	¿Recibió explicaciones claras sobre su condición y tratamiento?					
2	¿Le informaron oportunamente sobre los procedimientos a realizar?					
	EMOCIONES					
3	¿Se sintió tranquilo y seguro durante su atención médica?					
4	¿El personal de salud le trató con respeto y dignidad?					
	RESULTADOS					
5	¿Percibió una mejoría en su condición después del tratamiento?					
6	¿Está satisfecho con los resultados del tratamiento recibido?					
	BARRERAS					
7	¿Encontró dificultades para acceder a los servicios de salud que necesitaba?					
8	¿Tuvo dificultades para entender las indicaciones o recomendaciones médicas?					
	PERSONAL AUXILIAR					
9	¿El personal auxiliar (enfermeras, técnicos) fue amable y servicial durante su atención?					

10	¿Recibió el apoyo necesario del personal auxiliar durante su estancia en el centro de salud?					
----	--	--	--	--	--	--

Anexo 3. Validez del instrumento

Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [☒ X]

Aplicable después de corregir [☐]

No aplicable [☐]

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg. DNI:

Mag. Obst. Ana Maria Chicata Chavez

DNI 70918005

Especialidad del validador: Maestro en Salud Pública



28 de enero del 2025

¹ **Pertinencia:** el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **Relevancia:** el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable []

Aplicable después de corregir [x]

No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Mg. BENITES VIDAL, ELVIRA SOLEDAD

DNI:09578657

Especialidad del validador: Lic. En Obstetricia, especialista en atención Obstétrica de la Emergencia y cuidados críticos

14 de abril del 2025



COP: 7520

Firma del experto informante

¹ **Pertinencia:** el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **Relevancia:** el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [☐]

Aplicable después de corregir [x]

No aplicable [☐]

Apellidos y nombres del juez validador: Mg. BENITES VIDAL, ELVIRA SOLEDAD

DNI:09578657

Especialidad del validador: Lic. En Obstetricia, especialista en atención Obstétrica de la Emergencia y cuidados críticos

14 de abril del 2025



COP: 7520
Firma del experto informante

Título de proyecto de investigación: Calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia centro de salud “el pino”, lima, 2025

Investigadores : Angelica Milagros Bendezu Lucas

Institución(es) : Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW)

Estamos invitando a usted a participar en un estudio de investigación titulado: “Calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia centro de salud “El Pino”, lima, 2025”. de fecha 16/04/2025 y versión.01. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW).

I. INFORMACIÓN

Propósito del estudio: El propósito de este estudio es Determinar la relación entre la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”. Su ejecución permitirá Establecer la relación entre la dimensión fiabilidad, la seguridad, la empatía, los elementos tangibles, la calidad de atención y satisfacción en pacientes del servicio de obstetricia Centro de Salud “El Pino”.

Duración del estudio (en meses): 2 meses.

N° esperado de participantes: 260.

Criterios de Inclusión y Exclusión:

(No debe reclutarse voluntarios entre grupos “vulnerables”: presos, soldados, aborígenes, marginados, estudiantes o empleados con relaciones académicas o económicas con el investigador, etc. Salvo que la investigación redunde en un beneficio concreto y tangible para dicha población y el diseño así lo requiera).

Procedimientos del estudio: Si usted decide participar en este estudio se le realizarán los siguientes procesos:

- La recolección de los datos
- Serán analizados
- Serán procesados en la base de datos
- Se arrojarán talas de los resultados
- Serán analizados estadístico descriptivo y análisis inferencial de las correlaciones de acuerdo a las hipótesis

- Se realizará la discusión de resultados
- Conclusiones
- Recomendación del trabajo

La *encuesta* puede demorar unos 10 minutos.

Los resultados se le entregarán a usted en forma individual y se almacenarán respetando la confidencialidad y su anonimato.

Riesgos: *(Detallar los riesgos de la participación del sujeto de estudio)*

Su participación en el estudio *no* presenta _____.

Beneficios: *(Detallar los riesgos la participación del sujeto de estudio)*

Usted se beneficiará del presente proyecto _____.

Costos e incentivos: Usted no pagará ningún costo monetario por su participación en la presente investigación. Así mismo, no recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación.

Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información recolectada con códigos para resguardar su identidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al equipo de estudio.

Derechos del paciente: La participación en el presente estudio es voluntaria. Si usted lo decide puede negarse a participar en el estudio o retirarse de éste en cualquier momento, sin que esto ocasione ninguna penalización o pérdida de los beneficios y derechos que tiene como individuo, como así tampoco modificaciones o restricciones al derecho a la atención médica.

Preguntas/Contacto: Puede comunicarse con el Investigador Principal *(Detallar el nombre, número de teléfono y correo electrónico del investigador principal)*.

Así mismo puede comunicarse con el Comité de Ética que validó el presente estudio, Contacto del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica: Dr. Raúl Antonio Rojas Ortega, presidente del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la Universidad Privada Norbert Wiener, **email:** comite.etica@uwiener.edu.pe

II. DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

He leído la hoja de información del Formulario de Consentimiento Informado (FCI), y declaro haber recibido una explicación satisfactoria sobre los objetivos, procedimientos y finalidades del estudio. Se han respondido todas mis dudas y preguntas. Comprendo que mi decisión de participar es voluntaria y conozco mi derecho a retirar mi consentimiento en cualquier momento, sin que esto me perjudique de ninguna manera. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

_____(Firma)_____

Nombre **participante:**

Nombre **participante:**

DNI N°:

DNI N°:

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)

_____(Firma)_____

Nombre testigo o representante legal:

DNI:

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Nota: La firma del testigo o representante legal es obligatoria solo cuando el participante tiene alguna discapacidad que le impida firmar o imprimir su huella, o en el caso de no saber leer y escribir.